

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 26

Plan santé 2025



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

Introduction

Le Plan Santé 2025 s'inscrit dans le cadre des grandes orientations du Royaume du Maroc en matière de développement humain et s'adresse à un secteur à vocation éminemment sociale. De même, il répond aux engagements du Gouvernement d'inscrire son action dans des politiques publiques volontaristes, efficientes et coordonnées, au service du citoyen.

Au plan international, il répond aux orientations sanitaires mondiales telles que stipulées dans les conventions et accords-cadres internationaux auxquels souscrit le Maroc.

Ce plan intervient dans un contexte d'avancées notoires du Maroc en matière de politique de santé et de services de soins au citoyen. Mais également dans un contexte institutionnel porté notamment par la Constitution de 2011, qui fait de l'accès aux soins un droit à part entière, en réponse à une demande sociale croissante.

Le Maroc se trouve aujourd'hui confronté à de nombreux défis en matière de santé. Parmi les plus importants figurent l'accès équitable aux soins et la qualité des services rendus au citoyen, quel qu'il soit, afin de répondre aux insuffisances, combler les carences et ainsi réconcilier celui-ci avec son système de santé.

Le Plan Santé 2025 est fondé sur trois préalables :

1. Une vision claire et des valeurs partagées
2. Une analyse approfondie des principaux dysfonctionnements du système de santé, des problèmes de santé de la population et leur évolution, ainsi que des changements sociodémographiques
3. Une réponse aux besoins de la population quant à son accès aux soins, à la promotion de la santé et surtout à la qualité des prestations.

Le Plan Santé 2025 s'appuie sur 3 piliers :

Pilier 1 : organisation et développement de l'offre de soins en vue d'améliorer l'accès aux services de santé

Pilier 2 : renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies

Pilier 3 : amélioration de la gouvernance et optimisation de l'allocation et de l'utilisation des ressources

Ces 3 piliers se déclinent en 25 axes, 125 actions et près de 700 mesures opérationnelles.

Afin de reposer sur un fondement éthique, le Plan Santé 2025 s'appuie sur six valeurs :

Équité	Solidarité	Accessibilité
Qualité	Performance	Redevabilité

Enfin, un plan de santé en phase avec les stratégies nationales se doit d'être concerté, consensuel et fédérateur. Pour cela, le Ministère de la Santé a retenu une approche basée sur l'état des lieux, l'identification des axes d'intervention, les objectifs et résultats à atteindre, la priorisation et les moyens de mise en œuvre.

Cette démarche, innovante, s'est voulue participative grâce à l'association et l'implication des acteurs et partenaires du développement de la santé au Maroc : représentants institutionnels, praticiens et professionnels de santé, universitaires, membres de la société civile, secteur privé, hommes et femmes parties prenantes, à différents niveaux, au développement du secteur de la santé.

Contexte international

Secteur de première importance et à vocation sociale, la santé est tributaire des multiples enjeux qui affectent les politiques, les systèmes et les collectivités. Les objectifs du développement durable (ODD) constituent une plateforme de travail de premier ordre et sont de réels défis, du fait des transitions socio-économique, démographique et culturelle au niveau mondial et de l'inadéquation entre les besoins de santé et les ressources mobilisables.

Les cibles de l'objectif 3, « permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge », engagent le Maroc à poursuivre ses efforts pour l'amélioration de la santé et la promotion du bien-être de la population, à réduire les inégalités, à garantir la sécurité sanitaire et améliorer la réactivité et la réponse du système de santé aux changements climatiques, aux urgences de santé publique et aux catastrophes naturelles.

Mais le Maroc n'échappe pas aux autres défis mondiaux qui pèsent sur les pays, particulièrement ceux en transition :

1. La couverture sanitaire universelle (CSU)
2. La sécurité sanitaire internationale à travers l'application des dispositions du règlement sanitaire international 2005 (RSI 2005)
3. La pénurie en ressources humaines de santé
4. La maîtrise des déterminants sociaux de la santé

Par ailleurs, le Plan Santé 2025 s'inscrit dans la stratégie mondiale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) relative aux ressources humaines à l'horizon 2030, articulée autour de quatre objectifs principaux en matière de promotion du capital humain :

1. Optimiser la performance, la qualité et l'impact du personnel de santé à travers des politiques de ressources humaines s'appuyant sur les données factuelles, contribuant à assurer la santé et le bien-être des individus, une couverture sanitaire universelle effective, la résilience et des systèmes de santé renforcés à tous les niveaux.
2. Faire correspondre l'investissement dans les ressources humaines pour la santé aux besoins futurs de la population et des systèmes de santé, en tenant compte de la dynamique du marché du travail et des politiques d'éducation, de manière à pallier les pénuries et

améliorer la répartition du personnel de santé et parvenir ainsi à une amélioration maximale des résultats sur les plans de la santé, du bien-être social, de la création d'emplois et de la croissance économique.

3. Renforcer les capacités des institutions aux niveaux local, national, régional et mondial pour un leadership et une gouvernance efficace des mesures prises dans le domaine des ressources humaines pour la santé.
4. Renforcer les données concernant les ressources humaines pour la santé, pour le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des stratégies nationales et régionales et de la stratégie mondiale.

D'autre part, on citera la déclaration **d'Alma Ata (1978)**, où le Maroc s'est engagé à mettre l'accent sur l'adoption des soins de santé primaires (SSP) comme approche permettant d'assurer l'accès universel, l'équité sociale et la protection financière des plus démunis.

Cette déclaration est plus que jamais d'actualité, compte tenu des données attestant l'efficacité des SSP pour améliorer la santé, la stabilité sociale et la sécurité. En offrant des soins de proximité, les SSP permettent d'augmenter l'équité dans l'accès aux soins, de répondre de manière plus appropriée et réactive aux besoins spécifiques des populations et de s'engager sur une couverture sanitaire et territoriale plus homogène.

Les maladies non transmissibles (MNT) sont, à l'échelle mondiale, la principale cause de mortalité, véritable défi du 21^e siècle pour les pays aussi bien à haut, moyen ou faible revenu. **75 % des décès sont imputables aux MNT.** Depuis l'an 2000, plusieurs résolutions ont été adoptées afin d'appuyer les composantes de la stratégie mondiale pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles :

- | |
|--|
| 1. La convention-cadre pour la lutte antitabac |
| 2. La stratégie mondiale de l'alimentation et de l'activité physique |
| 3. La stratégie mondiale de réduction de l'usage nocif de l'alcool |
| 4. Le plan d'action de la stratégie mondiale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. |

En septembre 2011, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, lors de sa réunion de haut niveau, la Déclaration politique sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, avec entre autres mesures :

1. La réduction des facteurs de risque et l'instauration d'environnements sains
2. Le renforcement des politiques et systèmes de santé nationaux
3. Le renforcement des systèmes nationaux de surveillance et de suivi, y compris les enquêtes intégrées aux systèmes nationaux d'information sanitaire existants.

Parmi les risques pesant sur la communauté internationale figurent également les maladies transmissibles (MT), qui constituent toujours un lourd fardeau de morbidité et de mortalité.

L'OMS rapporte que la tuberculose, le paludisme, le VIH, l'hépatite virale et les maladies tropicales négligées (MTN) tuent encore plus de 4 millions de personnes annuellement. De même, l'organisation fait régulièrement état de la survenue d'épidémies de maladies infectieuses graves, notamment dans les pays à faible revenu : méningites, choléra, fièvres hémorragiques.

Dans toutes les sociétés de par le monde, les troubles mentaux représentent une charge de morbidité non négligeable.

L'OMS estime qu'**une personne sur quatre** dans le monde a souffert d'un trouble mental ou neurologique à un moment donné de sa vie, et 450 millions de personnes sont actuellement affectées par ces désordres ; 121 millions de personnes souffrent de dépression, 50 millions d'épilepsie, 24 millions de schizophrénie, et, chaque année, un million de personnes se suicident et 10 à 20 millions en font la tentative.

L'OMS estime aussi que 20 % des enfants souffrent de maladies mentales.

Toujours selon l'OMS, les troubles mentaux, neurologiques et liés à l'utilisation de substances psychoactives représentent 30 % de la charge de morbidité liée aux maladies non transmissibles et 12 % de la charge de morbidité mondiale (en 2020, ils seront responsables de près de 15 % de la perte d'années de vie corrigées de l'incapacité), et ils représentent 6 des 20 premières causes d'incapacité dans le monde.

Le Plan d'action global de l'OMS pour la santé mentale 2013-2020, approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé en 2013, reconnaît le rôle essentiel de la santé mentale dans la réalisation de l'objectif « **La santé pour tous** ».

Contexte national

L'état de santé de la population marocaine a connu une importante évolution au cours des dernières années. Les progrès dans les conditions de vie et l'accès aux soins ont contribué à l'amélioration de nombreux indicateurs démographiques et épidémiologiques :

1. Maîtrise de l'accroissement démographique
2. Progression de l'espérance de vie
3. Baisse de la charge des maladies transmissibles
4. Une augmentation de la charge des maladies chroniques et des traumatismes.

L'espérance de vie à la naissance est passée de 71,1 années en 2004 à 75,8 années en 2015. Le ratio de la mortalité maternelle a enregistré une réduction de 35 % entre 2010 et 2016, passant de 112 à 72,6 décès pour 100 000 naissances vivantes (NV).

La même tendance à la baisse a été constatée pour la mortalité infanto-juvénile : 22,6 décès pour 1 000 NV en 2018 contre 47 pour 1 000 NV en 2004.

Cette évolution s'effectue dans un contexte de transition démographique, avec l'inversion en cours de la pyramide des âges : le vieillissement de la population est un défi majeur. La proportion actuelle des personnes âgées de 60 ans et plus est de 11,1 %. Elle passera à presque 25 % d'ici l'an 2050.

Cette transition s'accompagne de l'amélioration des conditions d'hygiène grâce à l'extension du réseau électrique, du branchement à l'eau potable et de l'assainissement et grâce à la progression constante de la couverture sociale.

Cependant, la transition épidémiologique et démographique se traduit par une augmentation de la charge de morbidité et de mortalité des maladies non transmissibles : les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les maladies respiratoires chroniques et l'insuffisance

rénale chronique entraînent aujourd'hui 47 % des dépenses de santé, dont 46 % à la charge des ménages.

La consommation de tabac constitue à elle seule le quart des causes de cancer et plus de 8 % des causes de décès, selon l'OMS.

La situation est d'autant plus préoccupante que la couverture médicale ne s'adresse pas à la totalité de la population, avec un coût de prise en charge de ces maladies qui reste élevé.

De ce fait, la promotion de la santé et l'amélioration de l'accès aux soins constituent les meilleures approches stratégiques pour réduire le fardeau des MNT.

La maîtrise des maladies transmissibles s'est poursuivie durant ces dernières années. Ainsi, le Maroc est parvenu à inverser l'incidence de l'infection par le VIH. Il est aussi le 2^e pays de la région OMS/EMRO à éliminer le trachome cécitant. Globalement, la charge de morbidité des affections transmissibles et périnatales est passée de 33 % en 2000 à 18 % en 2016.

Dans le domaine de la santé de la reproduction, de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, le Maroc a enregistré des avancées notoires, comme l'atteste l'atteinte de l'OMD 4 et de l'OMD 5. A cet égard, la transition des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) vers les objectifs du développement durable (ODD) offre l'opportunité de repenser les stratégies nationales relatives à ce domaine et d'adapter les programmes.

Mais c'est certainement en matière d'accès aux soins que les acquis sont notoires, comme en témoigne la prise en charge des affections de longue durée.

Entre 2011 et 2016 :

- | |
|--|
| ○ Le nombre des diabétiques traités dans les structures publiques a augmenté de 40 % |
| ○ Le nombre des hypertendus suivis a été multiplié par 3 |
| ○ Le nombre des insuffisances rénales chroniques terminales (IRCT) prises en charge par le ministère en hémodialyse a augmenté de plus de 50 % |

L'ensemble de ces acquis a été rendu possible grâce, notamment, à l'amélioration de l'accès à l'hôpital public par l'amélioration de la fréquentation hospitalière de 80 %, l'augmentation des

hospitalisations et des consultations spécialisées, avec une nette progression de la capacité litière hospitalière suite à la mise en service de nouveaux hôpitaux publics et un nouveau CHU à Oujda.

Cette amélioration a également été favorisée par la facilitation de l'accès aux médicaments et dispositifs médicaux, avec des baisses de prix sur les spécialités et dispositifs médicaux, l'amélioration du taux de pénétration du générique, la baisse des dépenses directes des ménages bénéficiaires du RAMED et la baisse relative des dépenses globales des ménages en santé.

La consommation de médicaments a atteint 415 dirhams par habitant en 2016, inférieure à celle enregistrée dans les pays similaires. Mais la couverture sociale, en additionnant tous les régimes privés, concerne seulement 56 % de la population. A cela s'ajoute le faible budget alloué à la Santé qui se situe à 5,8 % du PIB, bien en dessous de la norme de 12 % préconisée par l'OMS.

Contexte institutionnel

Le Plan Santé 2025 est élaboré dans un contexte institutionnel national marqué par :

1. La Constitution du Royaume de 201
2. Le message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
3. Le discours de Sa Majesté le Roi du 14 octobre 2016
4. Le discours de Sa Majesté le Roi du 29 juillet 2018
5. Le programme gouvernemental (avril 2017)
6. Le partenariat public-privé (PPP)
7. La réforme de la loi organique des finances
8. La régionalisation avancée

Cadre de référence du Plan « Santé 2025 »

Dans la conception du Plan « Santé 2025 », une démarche participative a été adoptée en se basant sur trois niveaux de référence :

1. Les Hautes Orientations Royales
2. Les tendances sanitaires mondiales actuelles
3. Les engagements « santé » dans le Programme gouvernemental 2016-2021

Etat des lieux de la santé : défis et opportunités

Les infrastructures

Des progrès indéniables ont été enregistrés au Maroc depuis l'Indépendance en matière d'offre de soins. Ces progrès portent notamment sur l'extension du réseau des établissements de soins de santé primaires, des cabinets médicaux, des officines et cabinets dentaires, des hôpitaux et des cliniques privées et sur le développement des centres hospitaliers universitaires.

En termes de couverture de la population, la desserte globale du service public est passée d'un ESSP pour 14 600 habitants en 1990 à un ESSP pour 12 238 habitants en 2018. Malgré cette évolution favorable, plusieurs contraintes et dysfonctionnements sont à signaler, notamment :

1. La répartition inéquitable des différents établissements de santé entre le milieu urbain et le milieu rural et entre les régions
2. La desserte qui reste insuffisante pour répondre aux besoins de la population
3. Le retard accusé dans la mise en place de la carte sanitaire
4. La vétusté et le manque de maintenance du patrimoine immobilier et des équipements medicotechniques
5. La faible complémentarité entre le service public et le secteur libéral

Les ressources humaines

Le déficit quantitatif et qualitatif en ressources humaines est structurel et est aggravé par une distribution régionale déséquilibrée.

L'OMS situe le Maroc parmi les 57 pays du monde qui présentent une pénurie aiguë en personnel soignant. Actuellement, les effectifs du personnel médical et infirmier demeurent largement en deçà des besoins minimaux pour garantir à l'ensemble de la population une offre de soins de qualité. Les données indiquent que les médecins, dentistes, pharmaciens, sage-femmes et infirmiers exerçant dans le secteur public représentent un effectif de 47364 professionnels, soit un ratio de 7,3 médecins pour 10 000 habitants ou 22% et 9,2 infirmiers et techniciens de santé pour 10 000 habitants ou 56%.

La distribution régionale des professionnels de santé favorise largement les régions métropolitaines et les zones urbaines. 40 % des professionnels du public et 60% des professionnels

des deux secteurs sont concentrés dans les régions Casablanca Settat et Rabat-Salé-Kénitra où vivent 34 % de la population. La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ne dispose que de 11 % des effectifs du secteur public et de 8 % des effectifs des deux secteurs. Il en est de même pour les autres régions : Béni Mellal-Khénifra : 5 % pour les deux secteurs, Souss-Massa : 6 % pour les deux secteurs, Draa-Tafilalet : 3 % pour les deux secteurs, Laâyoune-Sakia Al Hamra : 2 % pour les deux secteurs.

Concernant le personnel infirmier, depuis 2008 24 294 lauréats sont sortis des instituts publics. La capacité actuelle de formation s'élève à 3000 étudiants par an toutes spécialités confondues, et 8600 étudiants en 2025.

Le médicament

Depuis les années 60, le Maroc a mis en place une politique pharmaceutique nationale afin d'améliorer l'accès aux médicaments et aux produits de santé et réglementer le secteur pharmaceutique.

Par ailleurs, le secteur a connu un développement en fonction de l'évolution socio-économique du Maroc et de l'évolution technologique du façonnage et du progrès thérapeutique. C'est ainsi que le Code de la pharmacie a été publié en 2005, suivi par un arsenal juridique comptant 20 textes législatifs et réglementaires spécifiques aux médicaments et à la pharmacie : 3 lois, 4 décrets et 13 arrêtés. Malgré tous ces efforts, plusieurs contraintes caractérisent encore le secteur du médicament

1. Les prix des médicaments qui restent élevés par rapport au pouvoir d'achat des Marocains comparé à celui de pays similaires
2. Les protocoles thérapeutiques qui ne sont pas généralisés
3. Le système d'approvisionnement et de gestion du médicament dans le secteur public qui est défaillant
4. La faible pénétration du générique

La couverture médicale

Aujourd'hui, 66 % de la population marocaine dispose d'une couverture médicale de base (AMO, y compris pour les étudiants, 31 % et RAMED 35 %), et en 2025 l'AMO couvre plus de 86% de la population, une avancée substantielle sur la voie d'une couverture globale. Le panier de soins, élargi et diversifié, inclut, entre autres, une longue liste de médicaments admis au remboursement et permet la prise en charge des affections lourdes et coûteuses (greffe d'organe, chirurgie à cœur ouvert, dialyse...). Une gamme importante de prestations liées à l'hospitalisation est concernée par l'application du tiers payant. Ce mécanisme a été élargi aux médicaments prescrits à titre ambulatoire, dans le cas des maladies cancéreuses.

La réglementation

Durant la dernière décennie, le Ministère de la Santé a connu une production importante de textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de la santé :

- La loi 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins
- La loi 65-00 formant code de la couverture médicale de base
- La loi 08-12 relative à l'Ordre national des médecins la loi 84-12 relative aux dispositifs médicaux
- La loi 109-13 complétant l'article 11 de la loi 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains
- La loi 131-13 relative à l'exercice de la médecine
- La loi 28-13 relative à la protection des personnes participant aux recherches biomédicales
- La loi 70-13 relative aux centres hospitalo-universitaires
- La loi 43-13 relative à l'exercice des professions infirmières
- Le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés
- Le décret n° 2-12-198 du 21 rejeb 1433 (12 juin 2012) relatif à la bioéquivalence des médicaments génériques
- Le décret n°2-14-562 du 7 chaoual 1436 (24juillet 2015) pris pour l'application de la loi-cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, en ce qui concerne

l'organisation de l'offre de soins, la carte sanitaire et les schémas régionaux de l'offre de soins

Les programmes de santé

Depuis les années 90, la santé de la mère et de l'enfant a toujours constitué une des toute premières priorités du secteur de la santé. Le taux de la mortalité maternelle a pu être ramené, selon l'Enquête nationale sur la santé de la population de 2017, à 72,6 décès pour 100 000 naissances vivantes, ce taux restant élevé par rapport aux pays de notre région.

Les causes évitables restent prédominantes : l'hémorragie du post-partum (43 %), les troubles hypertensifs (prééclampsie/éclampsie) (19 %), l'infection (7,2 %) et les complications de l'avortement (1,3 %). De plus, durant la période 2010-2016, les progrès ont été plus marqués en milieu urbain qu'en milieu rural : la réduction annuelle de la mortalité maternelle est de 7,9 % en milieu urbain contre 4,7 % en milieu rural, et le taux d'accouchement en milieu surveillé est de 96,6 % en milieu urbain contre 74,2 % en milieu rural (ENPSF 2018). Les soins en post-partum concernent seulement 22 % des femmes (ENPSF, 2011 et 2018).

Si le taux de mortalité néonatale a baissé de 38 % entre 2011 et 2018, passant de 21,7 à 13,6 décès pour 1000 NV, il concerne les trois quarts des décès des enfants de moins de 5 ans. Les principales causes relevées par l'étude multicentrique conduite sur les 4 CHU en 2009 sont : les détresses respiratoires (29,53 %), les infections (25 %) et la prématurité (19,65 %).

Par contre, entre 1987 et 1997, la mortalité infanto-juvénile a régressé de 95 % pour le tétanos néonatal (élimination certifiée par l'OMS en 2002), de 84 % pour la rougeole et de 86 % pour la coqueluche chez les enfants de 1 à 12 mois. Aucun cas de poliomyélite et de diphtérie n'a été déclaré respectivement depuis 1987 et 1998. Depuis l'introduction du vaccin spécifique en 2007, une réduction de 85 % des cas de méningite à *Haemophilus Influenza* type b a été notée. Pour la rougeole, le Maroc est considéré par l'OMS comme étant en phase de pré-élimination.

Par ailleurs, la prévalence contraceptive chez les femmes mariées de 15 à 49 ans a connu une bonne évolution, atteignant 70,8 % en 2018. L'utilisation des méthodes modernes est de 58 %, et les besoins non satisfaits sont de 11,3 % en 2018 contre 19,7 % en 1992.

Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les cancers féminins les plus fréquents au Maroc, avec une incidence standardisée respectivement de 45,5 et de 14,1 NC / 100 000 femmes¹. Depuis 2012, date de son institutionnalisation en tant que programme, la détection précoce du cancer du sein a été généralisée au niveau national, et la détection précoce du cancer du col de l'utérus est effective dans 42 provinces et préfectures. Si la détection précoce du cancer du sein a connu un franc succès (passage du taux de participation annuel de 6 % en 2010 à 36 % en 2017), la détection précoce du cancer du col de l'utérus est en cours d'extension. Pour ce nouveau programme, un investissement conséquent a été fait en matière d'infrastructure, d'équipement, de formation des professionnels de santé et de communication, grâce au partenariat avec la Fondation Lalla Salma - Prévention et traitement des cancers.

Les maladies non transmissibles

Au Maroc, la transition épidémiologique et démographique se traduit par une augmentation de la charge de morbidité et de mortalité des MNT telles que les cancers, le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'insuffisance rénale chronique.

Les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète et les maladies respiratoires chroniques représentent à eux seuls 47 % des dépenses de santé dont 46 % sont prises en charge par les ménages. La promotion de la santé et l'amélioration de l'accès aux soins constituent les meilleures approches stratégiques pour réduire le fardeau des MNT.

Se rapportant aux données des études réalisées au niveau national en matière de MNT, la charge de morbidité est résumée ci-dessous :

- Les résultats préliminaires de l'enquête STEPwise sur les MNT et leurs facteurs de risque, réalisée en 2017 par le Ministère de la Santé en collaboration avec l'OMS, chez les adultes de plus de 18 ans montrent une prévalence du diabète de 10,6 % et du pré-diabète de 10,4 %, une prévalence de l'HTA de 29,3 %, une prévalence de l'obésité de 20 % et de l'hypercholestérolémie de 10,5 %.
- Pour le tabac, cette enquête a donné une prévalence de 13,4 % (hommes 26,9 % et femmes 0,4 %) contre 18 % (hommes 31 % et femmes 3 %) en 2006 (Étude Maroc Tabagisme, 2006).

- Chez les enfants, selon l'enquête GYTS de 2016 (OMS), la prévalence du tabagisme chez les élèves âgés de 13 à 15 ans était de 6,4 %, alors qu'elle était de 11,7 % en 2006, grâce au programme national « Collège, Lycée et Entreprise sans tabac » lancé en 2007, en partenariat avec la Fondation Lalla Salma.
- L'incidence des cancers, d'après le Registre des cancers du Grand Casablanca pour l'année 2012, est estimée à 40 000 nouveaux cas par an.
- L'insuffisance rénale, selon l'enquête sur les maladies rénales au Maroc (Maremar) réalisée en 2011, a montré que la prévalence de la maladie rénale chronique avoisine les 3 %, soit environ 1 million de personnes concernées.
- Les maladies respiratoires chroniques, notamment l'asthme (environ 3,7 % chez l'adulte et 4,4 % chez l'enfant) et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (3,9 %) sont de véritables problèmes de santé publique au Maroc.

Les maladies transmissibles

Au Maroc, grâce aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles (MT), le fardeau de ces maladies s'est allégé depuis les années 80. Elles ne sont actuellement responsables que de 18 % des décès. Certaines maladies ont été éliminées. L'état des lieux des MT et de la réponse qui leur est réservée dans le système de santé marocain permet de distinguer trois groupes :

- Les maladies éliminées ou en cours d'élimination, réclamant la consolidation des acquis et le maintien de la vigilance : paludisme, trachome cécitant, schistosomiase, lèpre, poliomyélite et autres maladies-cibles du Programme national d'immunisation (PNI) (graphique 8).
- Les maladies constituant encore des problèmes de santé publique et nécessitant, de ce fait, d'intensifier les efforts et de renforcer les programmes de santé qui leur sont destinés : tuberculose, infection par le VIH, hépatites virales, méningite et certaines anthroozoonoses, notamment la rage, les leishmanioses et le charbon.
- Les maladies émergentes et/ou celles constituant des menaces d'urgences de santé publique, imposant le renforcement de la veille et la préparation du système de santé à la riposte : fièvres hémorragiques, infections respiratoires à nouveaux agents infectieux, maladies à transmission vectorielle, etc.

- Les leishmanioses et les toxi-infections alimentaires collectives représentent encore des problèmes majeurs de santé publique. Il en est de même du fléau des envenimations par morsure d'ophidien ou piqûre de scorpion.

La santé mentale

Les troubles mentaux représentent une charge de morbidité non négligeable.

Au Maroc, la santé mentale constitue un véritable problème de santé publique. L'enquête (ENPTM3) a mis l'accent sur la gravité de la situation : près d'une personne interrogée sur deux présente au moins un trouble mental, allant d'une simple insomnie ou d'un tic nerveux à des troubles plus graves tels que les troubles dépressifs, anxieux ou psychotiques ou les troubles liés à la consommation et/ou à l'abus d'alcool ou de drogues.

Au plan des infrastructures, on dénombre, pour une population supérieure à 34 millions d'habitants, 34 structures de soins psychiatriques et addictologiques réparties dans les différents réseaux d'établissements de santé (réseau hospitalier, réseau de soins de santé primaires et réseau d'établissements médico-sociaux).

La capacité litière totale est de 2 209 lits, soit une densité de 0,65 lit pour 10 000 habitants. Ce chiffre reste inférieur à la moyenne de la région EMRO (1 lit/10 000 habitants). On observe d'autre part une iniquité dans la répartition territoriale de ces structures. Actuellement, deux régions ne disposent pas encore de structure psychiatrique ou addictologique (DakhlaOued Eddahab et Guelmim-Oued Noun).

La population à besoins spécifiques

Ces dernières années, la population à besoins spécifiques bénéficie d'une attention soutenue de la part des pouvoirs publics et des politiques de santé. Cette population est constituée de quatre groupes :

1. Les personnes en situation de handicap

Qui représentent près de 7 % de la population du Maroc, dont 33,7 % sont âgées de 60 ans et plus. La prévalence du handicap, en nette augmentation à l'échelle mondiale, est aujourd'hui un réel défi pour le Maroc, compte tenu du vieillissement de la population et des pathologies afférentes à ce groupe.

2. Les personnes âgées

Dont 64,4 % sont atteintes au moins d'une maladie chronique en 2017, contre 57,5 % en 2011. Les prévalences du diabète et de l'hypertension artérielle sont respectivement de 20 % (22,9 % en milieu urbain et 15,3 % en milieu rural) contre 14,8 % en 2011 et 34 % (36,4 % en milieu urbain et 30,1 % en milieu rural) contre 28 % en 2011 (ENPSF, 2018).

3. La population carcérale

Estimée à 83 203 personnes (mars 2018), majoritairement des hommes (97,75%) et dont 80% ont moins de 40 ans. Il s'agit d'une population à la vulnérabilité accrue du fait du cumul de nombreux facteurs de risque (précarité socio-économique et sanitaire, faible accès aux soins...) et des conditions de détention parfois inadéquates (surpopulation et promiscuité).

4. La population immigrée

Qui bénéficie de la nouvelle stratégie du Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI (2014), en réponse à l'une des problématiques majeures auxquelles font face l'Afrique et l'espace euro-méditerranéen. Les dispositions prises en sa faveur sont basées sur des valeurs de solidarité, d'accueil et d'intégration.

Une vision pour 6 valeurs

Le Plan Santé 2025 est basé sur une vision claire :

Un système de santé cohérent pour une offre de soins organisée, de qualité et accessible pour tous, animée par des programmes sanitaires performants et supportée par une nouvelle gouvernance.

Cette vision est portée par des valeurs d'équité, de solidarité, d'accessibilité et de qualité, de performance et de redevabilité.

Équité

Le principe d'équité s'appuie sur un système de soins intégré et continu qui répond aux attentes de toutes les couches sociales, pour leur permettre de jouir du droit à l'égalité d'accès aux soins. L'équité renvoie également au principe de l'équilibre de genre, c'est à dire à un traitement juste, égal et durable entre les hommes et les femmes.

Solidarité

Le principe de solidarité prend tout son sens dans le domaine de la santé et particulièrement dans un contexte de forte demande sociale. Le système de santé doit d'abord donner la priorité aux populations pauvres et vulnérables, et cette solidarité permettra à moyen terme de tendre vers la couverture sanitaire universelle.

Accessibilité

Le Plan Santé 2025 va permettre de prodiguer des soins et des services de proximité adaptés à notre culture, à toute la population urbaine et rurale, de différents niveaux socio-économiques.

Qualité

Le Plan Santé 2025 s'appuie sur les différentes dimensions de la qualité des soins telles que préconisées par l'OMS. Des soins globaux, continus et intégrés, efficaces et efficients seront dispensés selon les principes d'innocuité et de sécurité des produits et des structures dans un cadre humanisé, par un personnel compétent et empathique.

Performance

Le Plan Santé 2025 va atteindre ses objectifs de promotion de la santé et va répondre aux besoins de la population de façon pertinente et efficace par rapport aux moyens disponibles. Un système de santé basé sur un système d'information fiable et innovant permet d'améliorer les indicateurs de l'état de santé de la population.

Redevabilité

Le Plan Santé 2025 va permettre la mise en œuvre d'un cadre de gouvernance efficient qui pratique la reddition des comptes et encourage la transparence, avec des principes de concertation internes et externes, d'accès à l'information et de développement de standards d'éthique et de conduite professionnelle.

Pilier 1

Organisation et développement de l'offre de soins en vue de d'améliorer l'accès aux services de santé.

Dans le but d'améliorer l'accès et la qualité des soins et de répondre aux attentes des citoyens, trois domaines ont été retenus dans ce premier pilier :

1. Les établissements de soins de santé primaires
2. L'Hôpital public
3. Les médicaments et dérivés sanguins

Ce pilier est décliné en **8** axes stratégiques, développés en **34** actions et **178** mesures spécifiques.

Les établissements de soins de santé primaires

Objectif principal

Réhabiliter la première ligne pour la rendre attractive et réactive.

Objectifs spécifiques

1. Disposer de centres de santé avec des équipes en mesure d'offrir des soins de qualité qui répondent à la majorité des problèmes de santé de la population (réduire les références vers les spécialistes et les délais de rendez-vous pour les patients nécessitant des soins hospitaliers).
2. Faire fonctionner les urgences médicales de proximité (CS) pour éviter les déplacements de la population vers les urgences hospitalières et leur encombrement.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre à la disposition de la population des services de première ligne accessibles, avec un personnel présent durant les heures de travail, un plateau technique de base fonctionnel et des moyens thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) ne connaissant pas de rupture, offrant des prestations acceptables culturellement et socialement. Ce dispositif doit s'appuyer sur un personnel compétent techniquement (bon diagnostic, traitement et suivi) et humainement (à l'écoute et respectueux de l'utilisateur), le tout à un coût abordable pour le système et pour l'utilisateur.

Axe 1 : Organiser l'offre de soins nationale

Action 1. Mettre en place les dispositions de la carte sanitaire.

Action 2. Poursuivre la validation et la mise en œuvre des SROS.

Action 3 : Créer des synergies entre le secteur public et le secteur privé, notamment à but non lucratif.

Axe 2 : Renforcer le réseau des ESSP, des EMS et de la santé mobile

Action 4. Ouvrir les structures fermées du réseau des ESSP répondant aux exigences de la carte sanitaire.

Action 5. Mettre à niveau les structures du réseau des ESSP dans le cadre du partenariat des DRS avec les conseils des collectivités territoriales.

Action 6 : Développer la stratégie mobile.

Action 7 : Poursuivre l'extension du réseau des établissements médico-sociaux (REMS).

Action 8 : Renforcer le rôle de la circonscription sanitaire comme territoire le plus décentralisé de planification, de suivi des programmes et d'encadrement des ESSP.

Axe 3 : Développer la médecine de proximité et la médecine de famille

Action 9 : Réhabiliter la médecine générale pour mieux répondre aux besoins et attentes de la population.

Action 10. Développer des soins intégrés centrés sur le patient.

Action 11. Adopter le régime de « médecine de famille, santé de famille et de la communauté ».

Action 12. Multiplier les caravanes sanitaires et les campagnes médico-chirurgicales en partenariat avec la société civile.

Action 13. Développer des actions de médecine solidaire au profit des populations et des territoires nécessiteux, en partenariat avec les facultés de médecine, les CHU et le secteur privé à but non lucratif.

L'hôpital public

Objectif principal

Assurer une offre hospitalière accessible, disponible, globale et prodiguant des soins sûrs et de qualité.

Objectifs spécifiques

1. Améliorer l'accessibilité de l'hôpital public : accessibilité géographique, financière et culturelle (image et perception).
2. Veiller à une offre hospitalière équitable et équilibrée, entre les régions et entre le milieu urbain et le milieu rural.
3. Améliorer la gouvernance de l'hôpital public : gestion basée sur la performance, l'efficacité et la rentabilité des ressources, l'équilibre financier et la compétitivité.
4. Assurer la sécurité et la qualité des soins hospitaliers : encouragement à l'implantation du processus qualité, généralisation des standards et normes de soins, obligation de l'accréditation des hôpitaux.

5. Coordonner l'offre ambulatoire et l'offre hospitalière : offres centrées sur le patient, continuité et globalité du service, système de référence et contre-référence.
6. Assurer une offre de prise en charge régionale et inter-régionale des urgences selon la carte sanitaire : urgences médicales de proximité, préhospitalières, hospitalières, continuité du service et qualité des soins.

Axe 4 : Développer le réseau hospitalier public

Action 15. Augmenter la capacité litière nationale globale moyennant la construction et la mise en service de nouveaux hôpitaux publics, avec un réaménagement des structures hospitalières existantes.

Action 16. Optimiser l'utilisation de la capacité litière existante en encourageant les modes d'hospitalisation non conventionnels (hôpital de jour, hôpital de semaine, hospitalisation à domicile...).

Action 17. Renforcer le plateau technique hospitalier et le mettre à niveau grâce aux technologies biomédicales récentes (veille technologique).

Action 18. Asseoir et mettre en œuvre une politique nationale de maintenance du patrimoine hospitalier actif et inactif.

Axe 5 Renforcer l'accès au réseau hospitalier et au réseau des ESSP

Action 19. Développer les soins tertiaires et la médecine hospitalo-universitaire.

Action 20. Améliorer la fréquentation hospitalière à travers l'amélioration de l'accueil et l'humanisation des services.

Action 21. Promouvoir la prise de rendez-vous à distance dans les établissements de soins.

Action 22. Œuvrer au respect des filières de soins par une meilleure articulation entre les structures qui réfèrent les patients et celles qui les reçoivent (référence / contre-référence).

Axe 6 Appuyer le plan national des urgences médicales

Action 23. Poursuivre le développement des SAMU / SMUR / HéliSMUR et promouvoir le SAMU social en collaboration avec les départements concernés.

Action 24. Étudier le déploiement d'avions sanitaires pour les transferts d'urgence.

Action 25. Développer le transport sanitaire spécifique aux urgences pédiatriques et aux urgences psychiatriques.

Action 26. Mettre à niveau les services des urgences et les services de réanimation.

Action 27. Créer des unités régionales de prise en charge des grands brûlés dans les CHR.

Les médicaments

Objectif principal

Rendre disponibles et accessibles les médicaments et les autres produits de santé, apportant des garanties de qualité, d'efficacité et de sécurité à la plus grande partie de la population.

Objectifs spécifiques

1. Assurer le maximum de sécurité aux patients en améliorant la qualité des médicaments et des autres produits de santé par le renforcement de la réglementation, notamment quant à la fabrication, la distribution, la délivrance, l'usage rationnel et la vigilance.
2. Entamer des actions synergiques pour la mise en œuvre des dispositions de l'écosystème médicament, en collaboration avec le Ministère de l'Industrie dans son volet matières premières et excipients, génériques, bio-similaires, dispositifs médicaux, recherche biomédicale, développement de l'innovation et de l'export.
3. Proposer un modèle de gouvernance approprié avec la vision, la stratégie et les procédures de mise en œuvre des mesures opérationnelles approuvées (création de l'Agence du médicament et des produits de santé).
4. Introduire dans l'ensemble des thématiques les valeurs d'éthique et le principe d'évitement des conflits d'intérêts.

Stratégie d'intervention

En vue d'atteindre les objectifs précités, un effort de priorisation des actions et de rationalisation des ressources est requis, sur la base d'actions prioritaires :

1. Améliorer l'accès aux médicaments et aux produits de santé par l'élargissement de la couverture médicale à la plus grande partie de la population
2. Renforcer l'offre de soins par l'augmentation du budget du Ministère de la Santé à 8 % du PIB à l'horizon 2025
3. Allouer des ressources humaines nécessaires pour assumer la mise en œuvre du PPN 2020-2025 réactualisé
4. Revoir à la baisse les mesures fiscales sur les médicaments et les produits de santé
5. Poursuivre la réactualisation de la réglementation des médicaments et des produits de santé aux standards internationaux (biosimilaires, produits de conseil, cosmétologie...)
6. Réglemente le système national de pharmacovigilance.

Axe 7 Améliorer l'accès au médicament et aux produits de santé

Action 28. Mettre en œuvre les dispositions de la Politique pharmaceutique nationale.

Action 29. Réadapter le cycle d'approvisionnement et de distribution des produits de santé.

Action 30. Optimiser la gestion et l'utilisation des produits de santé.

Action 31. Poursuivre la politique de contrôle des prix des médicaments et dispositifs médicaux.

Action 32. Améliorer le taux de pénétration du générique.

Axe 8 Améliorer l'accès aux produits sanguins sécurisés

Action 33. Promouvoir le don et la collecte de sang.

Action 34. Améliorer l'efficacité, la qualité et la sécurité des prestations du CNTSH et des centres de transfusion sanguine.

Pilier 2 :

Renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies

Dans le but de renforcer et de consolider les programmes nationaux de santé et de réduire la morbidité et la mortalité, 5 domaines sont abordés dans ce pilier :

1. Les maladies transmissibles
2. Les maladies non transmissibles
3. La santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent
4. La santé mentale
5. La santé des populations à besoins spécifiques.

Ce pilier est articulé autour de 8 axes stratégiques développés en 41 actions et 211 mesures spécifiques.

Les maladies non transmissibles

Objectif principal

Réduire la morbidité, la mortalité et les incapacités liées aux maladies non transmissibles à travers une action multisectorielle.

Objectifs spécifiques

1. Renforcer et/ou élaborer des plans stratégiques des MNT.
2. Mettre en place une filière pour la prise en charge des MNT.
3. Mettre en place les organes et les outils de gouvernance à tous les niveaux de compétence et de responsabilité.
4. Mettre en place un système de suivi-évaluation des MNT et de leurs facteurs de risque.
5. Mobiliser et disposer de ressources financières spécifiques pérennes.

Les principales lignes de force pour améliorer la gouvernance des MNT sont les suivantes :

- La mise en place d'un système de suivi-évaluation
- Le renforcement et la mise à jour de la législation et de la réglementation
- L'approche multisectorielle

- Le partenariat public-privé
- La mobilisation de fonds extra-budgétaires.

Axe 9 Renforcer les programmes de lutte contre les maladies non transmissibles

Action 35. Renforcer le plan national de prévention et de contrôle du cancer.

Action 36. Renforcer les programmes de lutte contre les MNT.

Action 37. Renforcer les programmes de lutte contre la cécité et la surdité et le programme de la santé bucco-dentaire.

Action 38. Développer et lancer le programme de conseils aux voyageurs, avec la promotion de la « médecine du voyage ».

Axe 10 Lancer de nouveaux programmes et stratégies sanitaires

Action 39. Lancer et mettre en œuvre le plan « Maroc sans hépatite virale C ».

Action 40. Lancer et mettre en œuvre le programme de prévention et de contrôle des maladies cardiovasculaires.

Action 41. Lancer et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre la surdité chez l'enfant.

Action 42. Lancer et mettre en œuvre la stratégie de lutte contre l'obésité de l'enfant.

Action 43. Lancer le plan national de la procréation médicalement assistée (PMA).

Action 44. Lancer et mettre en œuvre un programme national de lutte contre l'insuffisance rénale chronique (IRC).

Action 45. Lancer un plan national de promotion du don et de la greffe d'organes et de tissus humains.

Action 46. Lancer des programmes pour les maladies rares et inflammatoires et les maladies respiratoires chroniques.

Axe 11 Promouvoir des modes de vie sains et renforcer l'éducation pour la santé

Action 47. Lancer et mettre en œuvre un plan national multisectoriel des modes de vie sains.

Action 48. Renforcer et mettre en œuvre la stratégie nationale de la nutrition.

Action 49. Renforcer la communication en matière d'éducation sanitaire.

Action 50. Lancer la « chaîne santé publique » numérique via internet.

Action 51. Développer la « e-santé ».

Les maladies transmissibles

Objectifs principaux

1. Réduire la charge de morbidité et de mortalité des maladies transmissibles au Maroc, en vue de converger vers l'atteinte de la cible 3.3 des ODD en 2030.
2. Améliorer la sécurité sanitaire de la population à travers un système performant de veille et de surveillance pour la maîtrise des risques sanitaires, y compris ceux liés à l'environnement.

Objectifs spécifiques

1. Assurer une prise en charge diagnostique et thérapeutique de qualité pour les maladies transmissibles constituant encore des problèmes de santé publique.
2. Renforcer les capacités des structures d'appui aux programmes de lutte contre les maladies transmissibles, notamment le réseau des laboratoires de santé publique.

Préparer le système de soins à la prévention, la détection et la prise en charge des problèmes

Axe 12 Renforcer les programmes de lutte contre les maladies transmissibles

Action 52. Accélérer la riposte au VIH-Sida

Action 53. Accélérer la riposte contre l'infection par la tuberculose en vue d'atteindre les ODD.

Action 54. Renforcer le programme de lutte contre les anthroponoses.

Action 55. Lancer et mettre en œuvre le plan stratégique national de prévention et de contrôle de la résistance aux anti-microbiens (RAM)

Axe 13 Renforcer la veille et la sécurité sanitaires

Action 56. Lancer et mettre en œuvre le plan national de sécurité sanitaire.

Action 57. Renforcer les capacités de veille et de détection d'alerte et de riposte aux urgences de santé publique (USP).

Action 58. Renforcer le contrôle sanitaire aux frontières.

Action 59. Restructurer le réseau des laboratoires nationaux de référence.

La santé de la reproduction, la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent

Objectif général

Contribuer au bien-être de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent d'ici 2025.

Objectifs spécifiques

1. Réduire le ratio de la mortalité maternelle (RMM) de 72,6 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2018 à 48 pour 100 000 naissances vivantes à l'horizon 2025.
2. Réduire le taux de mortalité néonatale (TMN) de 13 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2018 à au moins 10 pour 1 000 naissances vivantes à l'horizon 2025.
3. Réduire le taux de mortalité des moins de cinq ans (TMIJ) de 21 décès pour 1000 naissances vivantes en 2018 à au moins 15 pour 1 000 naissances vivantes à l'horizon 2025.

La santé de la reproduction, la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent (SRMNEA)

Axe 14 Consolider les programmes de la « Santé de la mère et de l'enfant »

Action 60. Mettre en œuvre la politique nationale de la santé de l'enfant.

Action 61. Renforcer le programme de surveillance de la grossesse et de l'accouchement (PSGA).

Action 62. Créer des pôles d'excellence régionaux multidisciplinaires dédiés à la santé de la mère et de l'enfant et mettre à niveau les structures d'accouchement surveillé, notamment en milieu rural.

Action 63. Redynamiser le système national de suivi et d'évaluation de la santé de la mère et de l'enfant.

Action 64. Consolider le programme national d'immunisation (PNI) et y introduire le vaccin anti-HPV destiné aux filles de 9 à 13 ans.

Action 65. Généraliser le dépistage précoce à la naissance et prendre en charge certaines maladies chez les nouveau-nés.

La santé mentale

Objectif principal

Promouvoir, à travers le Plan national de santé mentale, le bien-être mental, prévenir les troubles mentaux et ceux liés à l'usage des SPA, prendre en charge les personnes qui en sont atteintes, améliorer leur fonctionnement social et promouvoir leurs droits fondamentaux à travers des actions coordonnées et intersectorielles.

Objectifs spécifiques

1. Promouvoir la santé mentale, prévenir et détecter précocement les troubles mentaux, notamment pour les personnes à risque.
2. Renforcer la capacité litère psychiatrique totale pour atteindre un ratio d'au moins 1 lit psychiatrique pour 10 000 habitants d'ici 2025.
3. Augmenter l'accessibilité aux soins et services diversifiés en santé mentale adaptés aux besoins des populations spécifiques (enfants, adolescents, jeunes, personnes âgées, personnes détenues, personnes en situation de handicap, personnes jugées irresponsables, migrants, sans abri...) et équitablement répartis sur le territoire.
4. Rendre disponibles et accessibles les psychotropes essentiels pour traiter au moins 80 % des troubles mentaux diagnostiqués au niveau des ESSP, d'ici 2025.
5. Améliorer la gouvernance et la qualité de l'information et des connaissances utiles à la planification et à la prise de décision.
6. Lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes de troubles mentaux et/ou addictifs.

Principes directeurs

Ce plan est régi par quatre principes majeurs :

1. Le rétablissement, qui suppose le partage du pouvoir avec les usagers et leurs familles et la reconnaissance des personnes atteintes de troubles mentaux ou présentant des conduites addictives comme des acteurs et des citoyens à part entière, et la reconnaissance de leurs droits fondamentaux (droit à l'autonomie, à la dignité, à l'information, à la participation aux décisions les concernant, aux soins et services...)
2. La diversification de la palette de soins et de services et son adaptation aux besoins des populations, dont les populations spécifiques
3. L'implication de la famille et des proches des PATM dans les décisions de services et de soins.
4. L'équité dans l'accès aux soins et dans la répartition des ressources.

Axe 15 Mettre à jour le Plan national de santé mentale et d'addictologie

Action 66. Mettre à niveau les hôpitaux et les services de psychiatrie intégrés existants, humaniser et normaliser les structures de soins et les pratiques professionnelles.

Action 67. Poursuivre la création de services intégrés de psychiatrie dans les hôpitaux généraux et diversifier l'offre de soins psychiatriques et les interventions en santé mentale.

Action 68. Œuvrer à la réinsertion sociale des personnes atteintes de troubles mentaux, la protection de leurs droits et la lutte contre leur stigmatisation et leur discrimination.

Action 69. Renforcer l'offre de soins et diversifier les services d'addictologie.

Promotion de la santé des populations à besoins spécifiques

Objectif principal

Assurer pour l'ensemble de la population en situation de vulnérabilité l'accès à des services de santé promotionnels, préventifs, de prise en charge et de réadaptation, de proximité et de qualité, adaptés aux spécificités de chacune des catégories.

Objectifs spécifiques

Populations en situation de vulnérabilité	Objectifs spécifiques des stratégies et plans d'action
Population en situation de handicap	-Réduire d'ici 2025 la proportion des personnes ayant des difficultés d'accès aux soins de 25% par rapport à 2014. -Augmenter d'ici 2025 la proportion des personnes couvertes par l'assurance maladie à 90% par rapport à 2014.
Personnes âgées	-Créer d'ici 2025 des services de prise en charge des personnes âgées malades en milieu hospitalier. - Augmenter d'ici 2025 de 100% l'effectif actuel des médecins gériatres. -Assurer la formation des auxiliaires de vie et développer les soins à domicile pour les personnes âgées dépendantes. -Élaborer des supports didactiques et pédagogiques.
Population carcérale	-D'ici 2025, que tous les établissements pénitentiaires disposent de centres médicaux assurant des actions de prévention et de promotion de la santé au profit des détenus. -Améliorer l'accès à des soins hospitaliers appropriés de 2e et 3e niveaux. -Mettre en place des mécanismes de coordination inter- et intra-départementale. -Garantir la continuité des soins pour les détenus libérés.
Population immigrée	-Disposer de connaissances et de données fondées sur les défis sanitaires liés aux flux migratoires pour assurer une riposte effective du système national de santé. -Contribuer à la réduction des problèmes de santé les plus fréquents chez les immigrés. -Assurer la prise en charge médicale adéquate des immigrés. -Instaurer des procédures et des mécanismes de gestion de la réponse nationale en matière de « santé et immigration ». -Renforcer les capacités requises du système national de santé.

Axe 16 Renforcer la promotion de la santé des populations à besoins spécifiques

Action 70. Accélérer la mise en œuvre du plan national « santé et handicap ».

Action 71. Renforcer l'offre de soins pour la population carcérale.

Action 72. Renforcer la mise en œuvre du programme national de la santé des femmes et des enfants victimes de violence.

Action 73. Lancer et mettre en œuvre la stratégie nationale de la santé des personnes âgées.

Action 74. Lancer et mettre en œuvre un plan stratégique national « santé et immigration ».

Action 75. Renforcer le programme de la santé scolaire, universitaire et de la santé des jeunes et des adolescents.

Pilier 3 :

Amélioration de la gouvernance et optimisation de l'allocation et de l'utilisation des ressources

Dans le but d'asseoir une bonne gouvernance du système de santé, d'optimiser l'allocation et l'utilisation des ressources, 4 domaines constituent la charpente de ce troisième pilier :

1. La couverture médicale de base
2. Les ressources humaines
3. La réglementation et le partenariat
4. Le système d'information, la performance et la qualité.

Ce pilier est structuré en 9 axes stratégiques, développés en 50 actions et 253 mesures spécifiques présentées ci-après.

Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle

Objectif principal

Élargir à l'horizon 2025 la couverture médicale de base (CMB) pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU).

Objectifs spécifiques

1. Établir un inventaire critique des réalisations en matière de mise en œuvre de la CMB en vue d'en identifier les forces et les faiblesses.
2. Définir les étapes à franchir et les mesures à prendre pour étendre d'une manière équitable la couverture à toute la population et améliorer la gouvernance du système d'assurance maladie.
3. Faire de la CMB un véritable outil d'accès aux soins, soutenable, pérenne, compréhensible et accepté par la population.
4. Disposer d'une vision globale et intégrée et d'une feuille de route pour atteindre la CSU.

Axe 17 Élargir la couverture médicale de base pour tendre vers la couverture sanitaire universelle (CSU)

Action 76. Couvrir progressivement toutes les populations, dont les travailleurs et professionnels indépendants non-salariés et les migrants.

Action 77. Renforcer le leadership du Ministère de la Santé sur la CMB et consolider le rôle régulateur de l'ANAM.

Action 78. Assurer la bonne gouvernance du RAMED à travers la création d'un organisme gestionnaire spécifique et œuvrer à la soutenabilité de son financement.

Action 79. Consolider l'AMO par la refonte des termes de la convention nationale et assurer un panier de soins minimal universel.

Action 80. Réduire le reste à charge et contrôler les dépenses à travers un parcours et un suivi médical coordonnés.

Action 81. Réviser la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) et renforcer les mesures de maîtrise médicalisée des dépenses.

Les ressources humaines

Objectif principal

Élaborer un projet de plan d'action national en matière de développement des ressources humaines de santé.

Objectifs spécifiques

1. Développer les capacités de planification, de normalisation des effectifs et de plaidoyer en vue de consolider l'augmentation des postes budgétaires.
2. Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage du déficit structurel et chronique en aides-soignants et autres métiers émergents.
3. Diversifier et encourager les modes de recrutement des professionnels de santé à travers le conventionnement, notamment avec les collectivités territoriales, le secteur privé... en vue de faire fonctionner prioritairement les centres de santé ruraux fermés.
4. Poursuivre l'adaptation du système de formation, y compris le cursus de formation, aux exigences des normes pédagogiques et aux évolutions des sciences de la santé.
5. Promouvoir le dialogue social dans le cadre de conventions d'entente avec les partenaires sociaux.
6. Poursuivre la modernisation de la gestion des ressources humaines de santé.
7. Instaurer des mécanismes de régulation de la formation publique et privée des professions de santé.
8. Actualiser et mettre en œuvre la stratégie sectorielle de formation continue.
9. Augmenter la capacité de formation en « médecine de famille et santé communautaire », via le e-learning.
10. Augmenter les effectifs d'admission pour la formation dans les établissements de formation du Ministère de la Santé.
11. Instituer une prime de rendement et mettre en place des mesures incitatives pour motiver et mobiliser les personnels de santé.

12. Mettre en place un programme national Santé et sécurité au travail (SST) axé sur la prévention et la gestion des risques professionnels chez le personnel de santé.

Axe 18 Pallier la pénurie en ressources humaines de la santé

Action 82. Développer les capacités de planification, de normalisation des effectifs et de plaidoyer en vue de consolider les augmentations de postes budgétaires.

Action 83. Concevoir et adopter un programme spécial de rattrapage du déficit structurel et chronique en aides-soignants et autres métiers émergents.

Action 84. Diversifier et encourager les modes de recrutement des professionnels de santé à travers le conventionnement, notamment avec les collectivités territoriales et le secteur privé, en vue de faire fonctionner prioritairement les centres de santé ruraux fermés.

Action 85. Poursuivre l'adaptation du système de formation, y compris le cursus de formation, aux exigences des normes pédagogiques et aux évolutions des sciences de la santé.

Action 86. Asseoir les conditions appropriées pour la création de la fonction publique sanitaire.

Axe 19 Améliorer les conditions de travail et motiver les professionnels de santé

Action 87. Promouvoir le dialogue social dans le cadre de conventions d'entente avec les partenaires sociaux.

Action 88. Promouvoir et poursuivre la modernisation de la gestion des ressources humaines de santé.

Action 89. Actualiser et mettre en œuvre la « stratégie sectorielle de la formation continue ».

Action 90. Augmenter la capacité de la formation en « médecine de famille et santé communautaire », via e-learning.

Action 91. Augmenter les effectifs d'admission pour la formation au niveau des établissements de formation du Ministère de la Santé.

Action 92. Instaurer des mécanismes de régulation de la formation publique et privée des professions de santé.

Action 93. Instituer une prime de rendement et mettre en place des mesures incitatives pour motiver et mobiliser les ressources humaines de santé.

Action 94. Mettre en place un programme national SST axé sur la prévention et la gestion des risques professionnels chez le personnel de santé.

La réglementation et le partenariat

Objectif principal

Viser l'amélioration du niveau de santé à travers la garantie de soins de qualité, répartis équitablement et à financement pérenne.

Objectifs spécifiques

1. Renforcer l'État de droit.
2. Institutionnaliser la concertation et la démocratie dans le système de santé.
3. Améliorer la gouvernance du système.
4. Promouvoir le partenariat.
5. Instaurer la synergie et la complémentarité entre le secteur public et le secteur privé.
6. Réorienter l'appui des partenaires internationaux vers des actions novatrices.
7. Renforcer la coopération Sud-Sud et promouvoir une coopération tripartite (Maroc-partenaires internationaux-pays africains).
8. Engager et responsabiliser les collectivités territoriales pour la mobilisation optimale des ressources.

Axe 20 Renforcer l'encadrement législatif et réglementaire du secteur de la santé

Action 95. Élaborer et publier les textes juridiques relatifs au secteur de la santé, inscrits dans le programme législatif et réglementaire du Gouvernement.

Action 96. Créer les instances de concertation prévues dans le cadre de la loi 34-09.

Action 97. Inscrire l'investissement en santé dans la charte nationale d'investissement.

Action 98. Élaborer un système de brevet des solutions développées dans le domaine de la santé.

Axe 21 Réviser l'organisation du secteur public de la santé

Action 99. Réorganiser le Ministère de la Santé au regard des exigences de la régionalisation avancée et créer des inspections régionales des services de santé.

Action 100. Créer l'Agence nationale de santé publique.

Action 101. Créer l'Agence nationale du médicament et des produits de santé.

Action 102. Créer l'Établissement marocain du sang.

Axe 22 Favoriser le partenariat et la concertation

Action 103. Promouvoir le partenariat avec les collectivités territoriales et les conseils de région.

Action 104. Accompagner l'investissement dans le secteur privé de la santé en conformité avec la carte sanitaire et encourager le tourisme médical en concertation avec les départements concernés.

Action 105. Créer des instances de concertation en matière de santé et dynamiser celles qui existent.

Action 106. Renforcer la coopération internationale en santé en l'orientant vers les priorités du département.

Action 107. Promouvoir la coordination intersectorielle.

Action 108. Consolider le système de doléances des usagers en régionalisant le traitement des plaintes.

Le secteur privé

Le système de santé se compose d'un secteur public, d'un secteur privé à but lucratif et d'un secteur privé à but non lucratif constitué par les fondations d'utilité publique telles que la Fondation Cheikh Zayed, la Fondation Cheikh Khalifa et le Croissant rouge marocain. Le Maroc dispose également d'un secteur de santé militaire.

Un secteur privé en développement constant

Le secteur libéral au Maroc s'est nettement développé durant ces trente dernières années, à la faveur de la création de nombreuses cliniques spécialisées, de laboratoires, de cabinets médicaux et d'officines, et par son extension dans tout le Royaume.

Selon le Ministère de la Santé, le secteur privé dispose de plus de 356 cliniques, avec environ 9 719 lits d'hospitalisation, 9 475 cabinets de consultation médicale : 276 cabinets de radiologie, 3121 cabinets dentaires, 4624 médecins généralistes et 7 518 médecins spécialistes. A côté des cliniques privées, un important réseau de plus de 8 914 officines s'est étendu sur l'ensemble du territoire. Le même développement a concerné les cabinets dentaires et les laboratoires de biologie avec un réseau de 531 cabinets et laboratoires.

Cette évolution est due à plusieurs facteurs :

1. L'attractivité du secteur privé pour les professionnels de la santé
2. La liberté du choix des lieux de travail (60 % des médecins privés sont installés à Rabat ou Casablanca)
3. La détérioration de la qualité des soins dans le secteur public, aussi bien au niveau des CHU que des autres hôpitaux, à l'exception de quelques établissements
4. L'augmentation considérable de la demande de services de santé privés, malgré des frais plus importants (70% des 20% de la population la plus pauvre utilise les services privés).

Les entraves au développement du secteur privé

1. L'absence d'une stratégie globale et intégrée associant le secteur privé en tant que partenaire stratégique aux objectifs de la santé publique.
2. L'absence d'une régulation concertée de l'implantation spatiale des établissements de santé privés en raison de l'inapplication des dispositions de la carte sanitaire.
3. L'inexistence d'outils d'évaluation du secteur privé et d'un système d'information fiable (répartition des professionnels, montant des dépenses et des ressources, données sur la qualité des soins, etc.).
4. La dualité des pratiques entre le secteur privé et le secteur public, avec une capacité limitée du Ministère de la Santé à appliquer la réglementation régissant le secteur privé.
5. La déficience dans la gouvernance et dans les modes de management des ressources.

6. La faible culture partenariale entre le public et le privé.

Proposition de stratégie de consolidation et de développement du secteur privé

Conformément à la loi 34-09 relative au système de santé et à l'offre de soins, le secteur privé en tant que partie intégrante de ce système est amené à jouer un rôle primordial dans la promotion et le développement du système de santé. Sa précieuse contribution doit être renforcée afin que son plein potentiel serve l'intérêt national.

Dans ce sens, il est devenu impératif d'entreprendre les actions stratégiques suivantes :

1. Développer une vision et une stratégie du rôle du secteur privé dans la couverture sanitaire universelle
2. Renforcer la gouvernance et la régulation du secteur privé
3. Développer un système d'information fiable
4. Intégrer l'information sur le secteur privé dans les systèmes nationaux d'information sanitaire
5. Développer le partenariat public-privé
6. Encourager l'investissement dans les régions sous-médicalisées.

Le système d'information, la performance et la qualité

Objectif général

Disposer d'un système d'information performant, basé sur le patient, et assurer la qualité des soins et la sécurité en permanence évaluées et améliorées.

Objectifs spécifiques

1. Déployer un système d'information moderne et intégré, reliant tout le système de santé et basé sur le dossier-patient.
2. Disposer de tableaux de bord avec des indicateurs de performance pour les différents secteurs de la santé.
3. Mettre en place une instance nationale dédiée à la qualité, la sécurité et l'accréditation des soins.
4. Mettre en place ou renforcer les structures chargées de la qualité dans les hôpitaux et les DRS.

Cette approche peut présenter certaines contraintes :

1. Une mise en place lente et complexe
2. Un niveau plus élevé de dépendance vis-à-vis du système informatique
3. Des résistances éventuelles au changement des outils actuellement utilisés.

Cependant, l'impact positif sur le patient et sa prise en charge et sur les établissements y compris les administratifs et les professionnels de santé est à même de permettre de dépasser ces contraintes.

Axe 23 Instaurer un système national d'information sanitaire intégré

Action 109. Mettre en place le schéma directeur informatique du Ministère de la Santé.

Action 110. Parachever le déploiement du système d'information décisionnel de la carte sanitaire (Base de données de l'offre de soins de la santé, banque de projets, système d'information géographique).

Action 111. Intégrer le secteur privé dans le système d'information du Ministère de la Santé.

Action 112. Concevoir, informatiser et implanter le « dossier médical partagé ».

Action 113. Créer le Datacenter du Ministère de la Santé.

Action 114. Mettre en place une politique de sécurité du système d'information.

Action 115. Informatiser le cycle d'approvisionnement en médicaments et digitaliser leur système logistique de distribution.

Axe 24 Améliorer le management et la performance des services de santé

Action 116. Instaurer un système moderne et intégré de facturation hospitalière.

Action 117. Développer l'autonomie hospitalière et introduire de nouveaux modes de gestion des hôpitaux publics, notamment en instaurant le statut de « groupement hospitalier régional ou de territoire » (GHR / GHT).

Action 118. Favoriser le mode d'organisation basé sur la spécialité et les pôles d'excellence dans les réseaux hospitaliers des grandes agglomérations.

Action 119. Procéder à la refonte du règlement intérieur des hôpitaux.

Action 120. Généraliser l'introduction des instruments d'audit et de contrôle de gestion dans le management des services de santé.

Action 121. Assurer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des dispositions de la Politique pharmaceutique nationale et veiller au respect des procédures d'octroi des AMM et CEDM selon la réglementation en vigueur.

Axe 25 Institutionnaliser la qualité et la sécurité dans le processus des soins

Action 122. Mettre en place un système d'évaluation des établissements de santé.

Action 123. Créer l'Agence de performance et d'évaluation hospitalières.

Action 124. Introduire les outils d'accréditation et de certification des services et des établissements de santé.

Action 125. Mettre en place une politique nationale de sécurité des soins basée sur des référentiels de prise en charge et des systèmes de vigilance.

Le financement du système de santé : des alternatives de financement

Selon le dernier rapport 2015 sur les comptes nationaux de la santé (CNS) 2013, la dépense totale de santé (DTS) s'élève à 52 milliards de dirhams (1 578 dirhams par habitant), enregistrant une augmentation de 4,2 milliards entre 2010 et 2013, mais, par contre, une baisse du poids de cette DTS dans le PIB, qui passe de 6,2 % en 2010 à 5,8 % en 2013. Le financement collectif et solidaire a gagné 3 points entre 2010 et 2013 (47 % contre 44 %), grâce surtout à la contribution de la couverture médicale qui est passée de 18,8% en 2010 à 22,4% en 2013, au moment où les ressources fiscales nationales et locales sont passées de 25,2 % en 2010 à 24,4 % en 2013.

Le passage progressif vers des approches alternatives du secteur de la santé

Il est prévu par le Plan Santé 2025 d'engager une concertation formalisée et structurée et un plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles auprès de l'ensemble des parties prenantes, dont le Ministère de l'Économie et des Finances, les départements ministériels, les institutions et autres partenaires concernés. L'objectif étant d'asseoir une stratégie de financement de la santé permettant au Maroc de se rapprocher progressivement des pays à économie similaire ayant réalisé un saut qualitatif de leur système de santé.

Par ailleurs, plusieurs pistes de diversification du financement du secteur de la santé ont été identifiées, qui constitueront les bases de la concertation avec le Ministère de l'Économie et des Finances :

1. Appliquer le principe pollueur-payeur
2. Restructurer la configuration financière
3. Diversifier les modes de financement en introduisant des mécanismes solidaires
4. Recourir au partenariat public-privé
5. Renforcer le partenariat avec le secteur privé
6. Créer des groupements hospitaliers régionaux (GHR)
7. Créer une société publique de droit privé
8. Activer/réactiver la composante « dons et legs »
9. Prévoir par un cadre réglementaire approprié permettant l'affectation d'une part des produits de placement et d'exploitation des waqf et habous au financement du RAMED
10. Assurer la régularité de la mobilisation des transferts des contributions destinées au financement du RAMED...